

병동 간호사 교육 및 실무용 프로토콜

1. 수술 전 준비사항 및 초기 간호

가. 자정(24:00) 이후 전면 금식 (NPO) 유지 상태 확인

- 수술 전날 밤 12시부터 물, 껌, 사탕을 포함하여 완전 금식 처방 이행 여부 점검 (마취 중 흡인성 폐렴 방지).

나. 고위험 지정 약물(항응고제/혈전용해제) 사전 중단 재확인

- 아스피린, 와파린, 플라빅스 등 출혈 유발 약물의 사전 중단 오더 이행 상태 차트 확인.

다. 환자 신체 위생 및 생체 모니터링 사전 세팅

- 산소포화도(SpO2) 측정 및 말초 순환 관찰을 위해 손발톱 매니큐어/젤네일 전면 제거확인.
- 보청기, 틀니, 피어싱, 반지 등 귀금속 및 안면/구강 내 이물질 최종 제거 후 수술실 입실.

라. 수술 전 경부 가동성 운동(Neck stretching) 교육

- 수술 중 장시간 목을 뒤로 과신전한 자세를 유지하게 되므로, 수술 전날 가벼운 목 스트레칭을 시행 하면 술 후 목 통증(뒷목 결림 등) 완화에 도움이 됨.

2. 수술 당일 및 입원 기간 의사 회진 프로토콜

가. 수술 당일 (수술 후 병동 회진 필수 참여)

- 환자가 수술 종료 후 병동으로 입실하면, 수술 당일 주치의 및 담당 의료진이 침상으로 방문하는 수술 후 회진에 반드시 참여하여 환자의 초기 상태를 공동 점검함.
- 회진 시 핵심 점검 사항: 수술 직후 의식 회복 상태, 활력징후(V/S), 수술 부위의 급격한 종창 및 출혈 여부, 호흡 양상, 배액관 음압 유지 상태를 대면 확인.

나. 입원 기간 정기 회진

- 수술 다음 날(POD 1) 아침 정기 회진을 통해 환자의 전반적인 상태를 평가하고, 배액관 유무에 따른 식사 진행 및 퇴원 여부를 최종 결정함. (전공의 및 진료지원간호사)
- 배액관이 없는 환자의 경우 수술당일 회진시 퇴원결정 및 통보
- 교수님 회진의 경우 수술(정규수술/응급수술) 및 외래 진료 일정으로 인해 회진시간 상이함

3. 배액관 삽입 환자의 초기 배액량 관리 지침

가. 수술 직후 간호 프로토콜:

- 1) 환자가 병동에 도착한 시점부터 첫 1시간 동안은 수술방에서 고여서 넘어온 혈액 및 초기 삼출물이 집중되므로, 1시간 동안 나온 배액량을 정확히 확인한 후 전량 버립니다(배액양상은 진료지원간호사에게 반드시 확인)
- 2) 이후(리턴 1시간 이후)부터 나오는 배액량부터 24시간 일일 총 배액량에 정상 기록합니다.

4. 수술 범위에 따른 입원 중 혈액검사 및 퇴원 기준

가. 전절제술(Total Thyroidectomy, T/T) 환자

- 핵심 지침:입원 기간 중 PTH(부갑상선 호르몬) 및 Calcium(칼슘) 수치를 연속적으로 F/U하여 저칼슘혈증(Hypocalcemia) 발생 여부를 정밀하게 확인하면서 퇴원을 진행함.

나. 반절제술(Hemithyroidectomy, H/T) 환자

- 반대편 부갑상선이 보존되므로 입원 중 루틴 PTH/Ca F/U 수치 확인 빈도가 낮으며, 그 외 모든 수술 후 출혈 모니터링, 상처 및 배액관 관리 기준은 전절제 환자와 동일하게 적용함.

5. 수술 후 배액관(Drain) 유무에 따른 식이 프로토콜

가. 배액관을 삽입하고 온 환자

- 1) 수술후 금식 or po제외 금식 유지, 수술 다음 날(POD 1) 아침, 배액관에 고인 삼출물 액체로 TG(중성지방) 검사처방 및 시행.
- 2) TG 검사 결과를 확인하여 유미액 유출(Chyle Leak) 음성 판정 등 안전성이 확보되면 최종 확인 후 식사(저지방 식이)를 시작.(회진과 상관없이 전공의, 진료지원간호사 확인)
- 3) 식사 진행 후 배액량이 임상적 안전 기준 수치 이하로 감소하면 주치의 판단하에 배액관을 제거하고 최종 퇴원 진행.

나. 배액관이 없는 환자

- 1) 전신마취가 완전히 풀리고 위장관 기능이 안정되면 별도의 검사 없이 조기에 일반식사로 즉시 전환.
- 2) 수술 부위의 출혈 징후가 없고 통증 조절이 안정적인 경우, 대개 수술 다음 날(POD 1) 오후 퇴원진행. 퇴원당일 오후 압박 붕대 제거.

6. 수술 환자 외래 추적 관찰 프로토콜

가. [Case 1] 월요일 수술 환자 스케줄

- 1) 1차 외래 (다음주 월요일 / 일반의 F/U)
 - 가) H/T (반절제):단순 경부초음파 (외래 처방 확인 및 접수 안내)
 - 나) T/T (전절제):단순 경부 초음파 + LAB 처방
 - T/T LAB 항목:CBC, ESR, CRP, Chemi, PTH, Ionized Ca

2) 2차 외래 (다음주 금요일 / 박재홍 교수님 F/U - 일반의 진료와 같은 주)

- 전체 환자 경부 초음파+LAB 처방
- CBC, ESR, CRP, Chemi, PTH, Ionized Ca, TFT, Vitamin D

나. [Case 2] 목요일 수술 환자 스케줄

1) 1차 외래 (다음주 수요일 / 일반의 F/U)

가) H/T (반절제):단순 경부 초음파 (외래 처방 확인 및 접수 안내)

나) T/T (전절제):단순 경부 초음파 + LAB 처방

- T/T LAB 항목: CBC, ESR, CRP, Chemi, PTH, Ionized Ca

2) 2차 외래 (그 다음주 화요일 / 박재홍 교수님 F/U - 일반의 진료 다음 주)

- 전체 환자 경부 초음파+LAB 처방
- CBC, ESR, CRP, Chemi, PTH, Ionized Ca, TFT, Vitamin D

7. 외래 당일 실무 주의사항 (환자 인계 필수)

가. LAB(혈액 검사) 시간 엄수: 모든 외래 혈액검사는 교수님/일반의 진료 시간 최소 2시간 전에 시행되어야 결과가 외래 진료 시 확인 가능함.

나. 초음파 검사 시간: 단순 초음파는 일반의 외래 진료 시간에 맞춰서 내원 및 검사하도록 일정 스케줄링 안내.

다. 복용중이던 아스피린, 와파린, 플라빅스 등 출혈 유발 약물등은 대개 수술후 5일째 복용시작, (퇴원시 반드시 확인)

라. 진단서는 최종 조직검사 결과 확인후에 발부 가능.